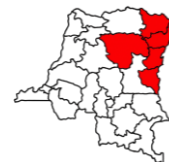




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°093/MVEBDB/16/08/2026

Date de rapportage : 16 août 2026

Date de publication : 17 août 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)



76 nouveaux cas confirmés de MVE ont été rapportés : 63 en Ituri, 11 au Nord-Kivu, 1 au Haut-Uélé et 1 à la Tshopo, sans nouvelle zone de santé touchée. 53 décès confirmés ont été enregistrés, dont 30 communautaires et 23 intra-CTE, tandis que 21 patients ont été déclarés guéris. Le suivi des contacts reste insuffisant à 82,2 %, avec une performance particulièrement faible au Bas-Uélé (18.9 %).

CUMUL DES CAS 5 021	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 2 378	LETALITE 47,4%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 751	CUMUL DES GUÉRIS 1 061	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 82,2 %
--------------------------------------	--	---------------------------------	---	---	---



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



55 Zones de santé touchées Sur 151
(36,4%)



246 Aires de santé touchées
Sur 3104 (7,9%)

Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Au **16 août 2026**, la transmission de la MVE demeure **active et géographiquement étendue**, avec **5 021 cas confirmés et 2 378 décès**, soit une létalité de **47,4 %**. L'**Ituri reste l'épicentre**, concentrant **84,8 % des cas cumulés**, tandis que la circulation du virus persiste également au Nord-Kivu, au Haut-Uélé et à la Tshopo.

L'épidémie affecte désormais **55 des 151 zones de santé** des six provinces touchées, avec une forte concentration en Ituri (**28/36 ZS**), suivie du Nord-Kivu (12/34), du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et du Bas-Uélé (1/11). **Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures.**

La situation reste néanmoins préoccupante au regard de la **mortalité persistante**, du **suiti insuffisant des contacts** et des disparités de capacités opérationnelles entre les provinces, justifiant le maintien d'une riposte intensive et ciblée dans les foyers actifs.

Répartition des cas et décès confirmés par province touchée
(Au 16 août 2026)

Province	Total cas confirmés	Total décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées	Nouveaux cas confirmés(24h)
Ituri	4257	1 878	44,1%	28/36 (77,8 %)	63
Nord-Kivu	607	428	70,5%	12/34 (35,3 %)	11
Haut-Uélé	139	63	45,3%	6/13 (46,1 %)	1
Tshopo	14	7	50,0%	7/23 (30,4 %)	1
Sud-Kivu	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)	0
Bas Uélé	1	1	100,0%	1/11(9,1%)	0
Total	5 021	2 378	47,4%	55/151 (36,4 %)	76

Cas et décès confirmés par province et zone de santé (situation du 16 août 2026)

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	4257	1878	44,1%	63	22	18	40
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	7	6	85,7%				0
Ariwara	7	2	28,6%				0
Aungba	11	5	45,5%				0
Bambu	109	25	22,9%				0
Boga	1	1	100,0%				0
Bunia	1174	358	30,5%	17	6		6
Damas	25	9	36,0%	2	0		0
Drodro	13	6	46,2%				0
Fataki	69	30	43,5%	5	0		0
Gethy	4	1	25,0%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	31	12	38,7%				0
Komanda	48	32	66,7%				0
Lita	181	102	56,4%	8	4		4
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	15	4	26,7%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	14	7	50,0%				0
Mandima	23	14	60,9%				0
Mangala	162	92	56,8%	6	4		4
Mongbwalu	590	282	47,8%	5	0		0
Nia-Nia	170	100	58,8%	6	4		4
Nizi	539	240	44,5%	5	1		1
Nyankunde	121	35	28,9%	1	0		0
Rimba	9	4	44,4%				0

Rwampara	856	331	38,7%	7	3		3
Tchomia	50	25	50,0%	1	0		0
A ventiler	NA	148	NA	NA	NA	18	18
Nord-Kivu	607	428	70,5%	11	7	4	11
Beni	93	70	75,3%	2	2		2
Butembo	112	95	84,8%	1	1	2	3
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	13	6	46,2%	1	1		1
Katwa	291	198	68,0%	6	3	2	5
Kyondo	15	12	80,0%				0
Lubero	1	1	100,0%				0
Mabalako	2	1	50,0%				0
Masereka	7	4	57,1%				0
Musienene	62	35	56,5%				0
Oicha	5	4	80,0%				0
Vuhovi	5	2	40,0%	1	0		0
Haut-Uélé	139	63	45,3%	1	0	1	1
Boma Mangbetu	22	8	36,4%				0
Gombari	1	1	100,0%				0
Isiro	42	20	47,6%			1	1
Pawa	20	14	70,0%	1	0		0
Rungu	1	0	0,0%				0
Wamba	53	20	37,7%				0
Tshopo	14	7	50,0%	1	1	0	1
Bafwasende	1	0	0,0%				0
Kabondo	3	2	66,7%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	5	4	80,0%	1	1		1
Mangobo	2	1	50,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				
Wanie-Rukula	1	0	0,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	1	1	100,0%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Total	5021	2378	47,4%	76	30	23	53

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable

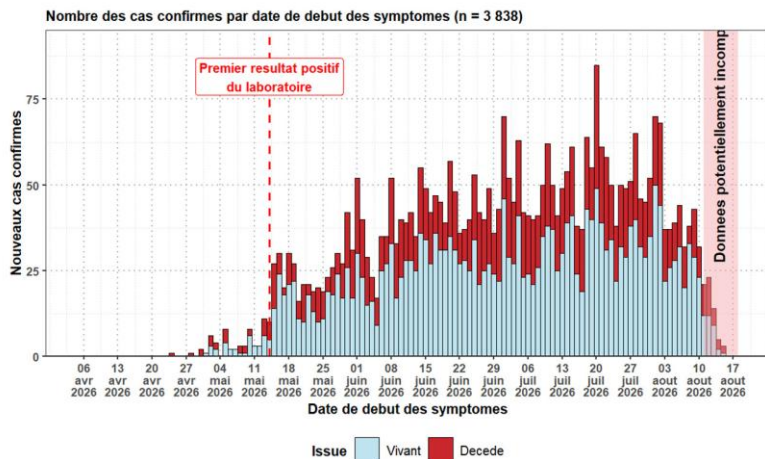
L'Ituri demeure le principal foyer de transmission avec 82,9 % des nouveaux cas et 40 décès confirmés du jour. Bunia, Lita, Rwampara, Mangala et Nia-Nia concentrent l'essentiel des nouveaux cas en Ituri. Le Nord-Kivu reste préoccupant avec une létalité de 70,5 %, tandis qu'un nouveau cas avec décès communautaire est rapporté à Makiso-Kisangani (Tshopo).

Situation des alertes notifiées par province, au 16 août 2026

DPS	Nouvelles Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	10	2	12	8	2	2	0	10	7
Bas Uélé	8	0	8	5	0	0	0	5	2
Ituri	298	42	340	84	40	119	0	124	66
Nord-Kivu	585	74	659	57	74	518	0	129	57
Sud-Kivu	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	48	0	48	2	0	46	0	2	2
Total Général	949	118	1 067	156	116	685	0	270	134

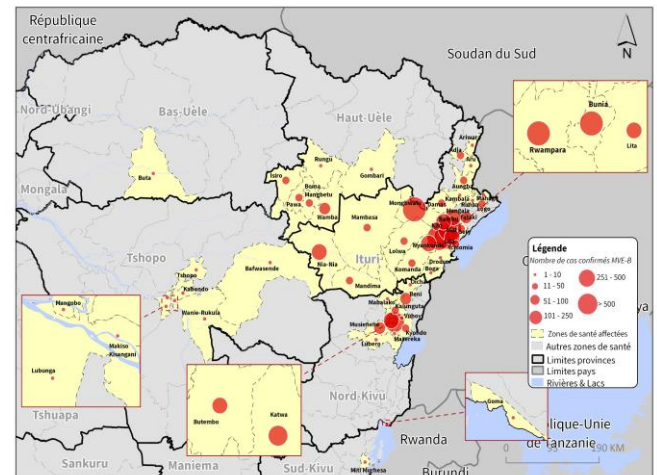
Les **1 067 alertes reçues** au cours de la journée sont principalement rapportées par le **Nord-Kivu (659 ; 61,8 %)** et l'**Ituri (340 ; 31,9 %)**, qui concentrent ensemble près de **94 % des alertes**. Parmi les alertes vérifiées, **272 ont été validées comme cas suspects**, dont **116 décès**, traduisant une proportion importante d'alertes de décès. Au total, **270 suspects ont été investigués et 134 transférés vers les CT/CTE**. La forte proportion d'alertes invalidées au Nord-Kivu (**518**) mérite une analyse afin d'apprécier la qualité et la spécificité du système d'alerte. **Les données du Sud-Kivu sont non disponibles (ND)** pour la période considérée.

Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours



Source : DHIS2 Tracker - Riposte MVE, août 2026. Données incluses : cas confirmés avec statut vital et date de début de symptômes renseignés, n = 3 838.

Cartographie des cas de 21 derniers jours



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Nord-Kivu** : Participation à la remise officielle d'une ambulance à la ZS de Kyondo (appui du Gouvernement) par la délégation de la Ministre provinciale de la Santé, visite des CTE de Katwa et de Kitatumba, participation à la réunion de surveillance et de coordination de la ZS de Beni et visite d'évaluation de la prise en charge au CTE de Kitatumba (Butembo) avec l'équipe ougandaise.

- **Ituri/Tshopo** : Mise en place d'une équipe de revue des alertes invalidées, renseignement des reports d'alertes et création d'une équipe d'analyse des présentations ;
- **Haut-Uélé** : Supervision des activités d'évaluation des activités PoE avec le facilitateur ;
- Dans le contexte de l'extension géographique de l'épidémie, **l'Incident Manager (IM) a effectué des missions dans le Haut-Uélé et le Bas-Uélé**, notamment à **Isiro et Buta**, afin d'évaluer la situation, renforcer la coordination provinciale et accélérer la mise en œuvre des mesures de riposte. Une attention particulière a été accordée au **renforcement de la surveillance et du suivi des contacts, à la sécurisation du corridor Isiro-Buta, au renforcement du triage et des capacités de prise en charge, ainsi qu'à la coordination transfrontalière entre les deux provinces** pour limiter davantage l'extension de l'épidémie.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au terme de la journée du 16 août 2026, 1 067 alertes ont été enregistrées, dont 957 (89,7 %) ont été vérifiées dans les cinq provinces ayant rapporté. Parmi celles-ci, 272 (28,4 %) ont été validées comme cas suspects et 270 (99,3 %) ont été investiguées, desquelles 134 (49,6 %) ont été transférées vers les CT/CTE. La province du Sud-Kivu n'a pas transmis des données. La proportion des contacts suivis au cours des dernières 24 heures remonte à 82,2 % (16 130 vus sur 19 630 à suivre), au-dessus du seuil de 85 % : Ituri 82,4 % (8 855/10 746), Tshopo 100 % (439/439) et Nord-Kivu 80,5 % (5 805/7 214). Le Haut-Uélé 83,8% (1 031/1 231) et Bas Uélé 18,9% (35/185). Signalons que 11 zones de santé n'ont pas rapporté dans la DPS Ituri et le Sud-Kivu ne compte plus de contact actif.

2.1.2. Défis

Persistance d'insuffisances dans le suivi des contacts et la complétude du rapportage, avec une proportion globale de contacts suivis de **82,2 %**, **encore inférieure au seuil attendu de 85 %**, une situation particulièrement préoccupante au **Bas-Uélé (18,9 %)**, ainsi que la **non-transmission des données par 11 zones de santé de l'Ituri et par le Sud-Kivu**, limitant la détection précoce des cas et la maîtrise des chaînes de transmission.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

2.2.1. Principales actions

- Sept (7) alertes ont été détectées aux différents PoE/PoC au cours des dernières 24 heures : cinq en Ituri et deux au Nord-Kivu. Le détail des actions menées à chaque point de contrôle est présenté ci-dessous, par province.

Suivi des indicateurs aux PoE/PoC par province, en date du 16 août 2026				
Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Proportion de PoC activés et PoE renforcés	100 % (60/60)	100 % (18/18)	35,0 % (7/20)	87,9 % (94/107)
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	128 551	77 138	2 998	208 687
% des voyageurs screenés	96,0 %	96,92 %	99,3 %	96,4 %
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,0 %	96,92 %	99,1 %	97,0 %
% des voyageurs sensibilisés	99,5 %	96,92 %	100 %	98,6 %

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Nombre d'alertes notifiées	5	2	0	7
Nombre d'alertes vivantes validées	3	2	0	5
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	1	0	0	1
Nombre de contacts à problème interceptés ce jour	0	0	0	0
% d'alertes vivantes validées référées au CT/CTE	33,3 % (1/3)	100 % (2/2)	0	60,0 % (3/5)
% des corps sans vie swabés	100 % (1/1)	0	0	100 % (1/1)

2.2.2. Défis

Suivi sous-optimal des contacts, particulièrement au Bas-Uélé, et insuffisance de complétude du rapportage, compromettant la détection précoce et l'interruption rapide des chaînes de transmission.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

L'Ituri a enregistré 63 nouveaux résultats positifs (41 vivants et 22 décès) parmi les 248 nouveaux échantillons reçus et analysés (Taux de positivité : 25,4%). De plus, 13 prélèvements sont revenus positifs parmi 78 échantillons analysés. Le Nord-Kivu a confirmé 11 nouveaux cas dont 7 décès parmi 144 échantillons analysés (Taux de positivité : 7,6%), le Haut-Uélé une confirmation à Pawa parmi les 8 échantillons (Taux de positivité : 12,5%) et la Tshopo 1 cas confirmé parmi les 4 échantillons reçus et analysés (25%).

1.4.2. Défis

Maintien d'une forte positivité en Ituri et détection encore tardive de certains cas, notamment à travers les prélèvements post-mortem, témoignant de chaînes de transmission communautaire persistantes.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 97 rings étaient attendus (80 reports de la veille et 17 cas confirmés retenus) et 21 rings ont été effectivement ouverts ; 48 sites ont été identifiés et décontaminés. Les motifs de non-réalisation sont l'insuffisance des équipes et des intrants de décontamination (Mandima, Bambu-mine, Mangala), la résistance des familles (Kilo), les adresses non retrouvées, l'insécurité et la grève des décontamineurs.
- **Au Nord-Kivu**, 44 alertes de décès ont été reçues avec 12 reports, 43 corps ont été prélevés par swab et 41 EDS réalisés, pour 14 reports au jour suivant ; un échec est signalé, lié à la résistance communautaire dans la ZS de Kalunguta. Les décès rapportés se concentrent à Katwa (17, soit 38,6 %) et à Beni (16, soit 36,3 %).
- **Au Haut-Uélé**, 1 alerte de décès a été enregistrée avec 1 report, pour 2 corps prélevés par swab et 2 EDS réalisés (100 %), sans échec signalé. Dix superviseurs PCI de la ZS d'Isiro ont été briefés avant le démarrage des supervisions et 14 ESS demeurent sous surveillance PCI. À la Tshopo, le ring du 15^e cas a été ouvert, l'HGR Cinquantenaire (1 ambulance et 2 locaux) et la Clinique ART ont été décontaminés, et le score card de l'HGR Cinquantenaire s'établit à 48 %.

2.4.2. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : ouverture de rings limitée en Ituri (21 sur 97) et décontamination incomplète (48 sites sur 97) du fait de la grève des décontaminateurs, de l'insécurité, des refus et des adresses non retrouvées ; complétude du rapportage PCI limitée à 9 zones de santé sur 14 en Ituri ; insuffisance d'EPI et de personnel formé à la Tshopo, où deux incinérateurs sont en panne à l'HGR de Makiso-Kisangani.

2.5. Continuité des soins

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 32 ambulances sont disponibles sur 34 (94 %), dont 16 utilisées (50 %) pour 28 courses réussies sur 28 (100 %) et une capacité de réponse de 28/39 (72 %). Les CTE/CT ont enregistré 127 nouvelles admissions toutes suspectes, dont 7 en phase avancée (3 Mongbwalu, 1 Bambu et 3 Mangala) et 98 sorties dont 18 guéris. Ainsi, 577 patients sont hospitalisés (235 confirmés et 342 suspects) dont 43 enfants de moins de 5 ans, pour 991 lits, soit un taux d'occupation global de 58,2 %. Les CTE de Bambu et Mangala (confirmés et suspects), de Nizi (confirmés) ainsi que de Fataki, Kilo et Kigonze (suspects) sont saturés.
- **Au Nord-Kivu**, 48 nouvelles admissions ont été enregistrées (3 confirmés et 45 suspects), pour 48 sorties dont 2 guéris au CTE de Kitatumba. Ainsi, 170 malades sont hospitalisés (32 confirmés et 138 suspects) dont 19 enfants de moins de 5 ans, pour 206 lits, soit un taux d'occupation global de 82,5 %.
- **À la Tshopo**, deux nouvelles admissions ont été enregistrées au CTE HC de Kisangani (un cas confirmé/PPL) et un cas suspect, pour 4 sorties non-cas et 1 décès confirmé survenu sur un tableau d'anémie sévère. Cinq patients sont en isolement au CTE HC de Kisangani pour 12 lits, soit 41,7 % d'occupation.

2.5.2. Défis

Saturation de plusieurs CTE/CT en Ituri et forte occupation des capacités au Nord-Kivu, associées à des admissions tardives de certains patients, mettant sous pression la continuité et la qualité de la prise en charge.

2.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

2.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 330 nouveaux contacts ont été listés autour des cas du jour. Un dialogue communautaire sur la prévention de la MVE a réuni 100 participants autour du chef de chefferie Bahema Irumu (ZS de Rwampara). Un plaidoyer a été mené auprès du chef du groupement Babonde à Nia-Nia (frontalier du Haut-Uélé) et 18 jeunes leaders ont été briefés sur la CREC en appui à la surveillance à base communautaire (ZS de Lita). La communication autour de 10 cas confirmés a touché 49 responsables de ménage à Rwampara.
- **Au Nord-Kivu**, les équipes ont appuyé le listage de 44 contacts à Kanzulinzuli (ZS de Beni), la recherche d'un cas suspect évadé à Luotu (ZS de Kyondo) et la levée des réticences liées au suivi des contacts à Musienene. Sur le plan psychosocial, 385 personnes (253 femmes et 132 hommes) ont bénéficié de séances de psychoéducation et 18 enfants séparés et/ou orphelins ont été accompagnés.
- **Au Haut-Uélé**, 345 personnes ont été touchées lors des visites à domicile dans 69 ménages, 276 lors des causeries éducatives (ZS de Wamba et d'Isiro) et 5 688 lors des sensibilisations de masse dans les églises et marchés d'Isiro, de Boma-Mangbetu et de Pawa ; 5 radios ont diffusé les messages de prévention et 41 outils IEC ont été distribués (cumul de 340). À la Tshopo, 12 642 personnes ont été sensibilisées dans les confessions religieuses et la communication a été assurée autour des cas confirmés de Mangobo et de Makiso-Kisangani.

1.1.1. Défis

Persistance des réticences au suivi des contacts et de comportements à risque, notamment l'évasion de cas suspects, malgré l'intensification de la communication et de l'engagement communautaire.

2.7. Logistique

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 43 colis de kits PCI pesant 127 kg ont été livrés à la ZS de Fataki, 10 ambulances ont été affectées sur le terrain et 3 véhicules de location ont été déployés sur les axes Adja, Mambasa, Kilo et Damas ; un nouveau bâtiment du CTE de Mongbwalu est opérationnel avec une capacité de 60 lits. Les besoins portent sur 4 boîtes à gants (ZS de Fataki, Bambu-mine, Lita et Rwampara) ainsi que sur les cryotubes et cryoboxes ; quatre laboratoires mobiles sont projetés dans ces mêmes zones de santé
- **Au Nord-Kivu** : Evaluation du site d'implantation du CTE à l'ITAV, réunions avec les sous-coordinations des ZS de Kyondo et de Katwa et remise d'une ambulance à la ZS de Kyondo sur appui du Gouvernement ; six ambulances sont disponibles et utilisées.
- **Au Haut-Uélé** : Briefing des prestataires et l'installation des kits (appui OIM). À la Tshopo : réception de 23 kits Starlink (OMS), dotation de 85 thermoflashs par le PNHF national, poursuite de la construction des deux isolements et du CTE de grande capacité, et approvisionnement en eau du PoC de PK 23.

2.7.2. Défis

Persistance de gaps en intrants critiques, capacités de laboratoire et infrastructures de prise en charge/isolément dans certaines zones affectées, malgré le renforcement logistique en cours.

2.8. Sécurité

2.8.1. Principales actions

- La sécurisation des activités de la riposte s'est poursuivie, notamment par l'appui du service de sécurité au transfert des cas suspects réticents à la Tshopo et par la remise de la liste des perdus de vue aux services de sécurité et aux PoE/PoC. Au Haut-Uélé, une descente conjointe CREC, SMSPS, PCI et surveillance a permis d'annoncer deux résultats positifs dans un ménage résistant à l'EDS et d'obtenir son adhésion au CTE.

2.8.2. Défis :

Persistance des réticences communautaires et des perdus de vue, nécessitant un renforcement de la coordination sécuritaire pour garantir leur localisation et leur orientation vers les structures de prise en charge.

2.9. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

2.9.1. Principales actions

- Poursuite des activités de sensibilisation sur la Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels (PSEA) dans les provinces touchées. Aucune donnée journalière n'a été transmise par le pilier pour la période considérée ; les activités rapportées lors du précédent cycle se poursuivent.

2.9.2. Les défis

Faible couverture et insuffisance du rapportage des activités PSEA, limitant le suivi des mécanismes de prévention, de signalement et de gestion des cas.

2.10. Base des données

2.10.1. Principales actions

- Poursuite de la réunion technique consacrée à la finalisation de l'analyse et de l'assainissement des bases de données de la riposte. Les travaux ont porté sur la vérification de la complétude et de la cohérence des données, l'identification et la correction des doublons et incohérences, ainsi que l'harmonisation des différentes bases utilisées par les piliers. Cette démarche vise à disposer d'une base consolidée, fiable et actualisée, permettant d'améliorer la qualité des indicateurs, le suivi de l'évolution de l'épidémie et la prise de décision.

2.10.2. Défis

Insuffisance persistante de la qualité, de la complétude et de la promptitude des données, ainsi que de difficultés d'harmonisation des différentes bases de données de la riposte.

MESSAGES CLES

La transmission de la MVE demeure active et préoccupante, avec 76 nouveaux cas et 53 décès au cours des dernières 24 heures, l'Ituri restant l'épicentre et le principal foyer d'expansion de l'épidémie. Malgré une investigation quasi exhaustive des cas suspects (99 %), le suivi des contacts reste sous-optimal (82,2 %), nécessitant d'intensifier les interventions dans les zones à forte transmission et de renforcer la surveillance, la prise en charge précoce, la PCI et l'engagement communautaire afin d'interrompre les chaînes de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des 64 et de soutien.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John



Contact :

www.sante.gouv.cd

contact@sqiebola17.org

Numéro vert : 151.